ONEMA-POP-009 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-009 — Triagem de Complicações Infecciosas e Mecânicas em Cateter Venoso Central — PICC e Port-a-Cath

1. Identificação institucional

983558

2. Objetivo e abrangência

Detectar precocemente infecção, trombose, migração, ruptura e outras complicações de acesso venoso central e interromper uso inseguro. Atendimento domiciliar presencial ou orientação digital conforme indicação; não substitui assistência de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado com capacitação específica em acessos vasculares; manipulação, curativo, coleta ou infusão somente sob protocolo, prescrição e técnica compatíveis com dispositivo e fabricante. Indicações: Febre, calafrios, eritema, secreção, edema, dor, dificuldade de infusão, vazamento, migração ou dano em PICC/port.
Limites/contraindicações: Não utilizar ou testar permeabilidade sob pressão quando houver dor, resistência, vazamento, alteração do comprimento externo, suspeita de trombose, ruptura ou infecção. Não retirar CVC sem indicação/protocolo específico.

4. Materiais e responsabilidade de fornecimento

Enfermeiro: EPI, termômetro, aparelhos de sinais vitais, material estéril para proteção/curativo conforme indicação, telefone e ficha do dispositivo; materiais de manipulação compatíveis com fabricante somente se procedimento autorizado. Paciente: cartão de identificação do cateter, informações de implantação e insumos previstos no contrato.

5. Avaliação e preparação

Identificar tipo de dispositivo, data de implantação, indicação, local e comprimento externo basal no PICC, infusão atual, histórico de culturas, temperatura, sinais sistêmicos, dor, edema do membro/pescoço, rubor, secreção, extravasamento e
integridade.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar tipo de cateter, indicação e se há infusão em curso; perguntar quando começaram os sinais e registrar

valores basais e eventos recentes.

2. Triar imediatamente febre com calafrios intensos, hipotensão, confusão, dispneia, dor torácica, edema importante ou

suspeita de embolia; acionar SAMU 192 diante de instabilidade.

3. Na presença de dor, vazamento, ruptura, resistência, migração ou suspeita infecciosa, interromper uso do acesso

conforme segurança da infusão e acionar equipe prescritor/serviço de referência; não realizar flush forçado.

4. Inspecionar sem manipulação desnecessária: curativo, pele, conexão externa, comprimento visível do PICC, edema e

secreção; não acessar port implantado apenas para “testar” patência.

5. Registrar sinais vitais e achados, incluindo diferenças em relação ao comprimento externo previamente documentado;

preservar curativo estéril e integridade do sistema.

6. Encaminhar no mesmo dia para avaliação clínica de suspeita de infecção ou trombose; casos sistêmicos graves

exigem emergência, não aguardar cultura domiciliar.

7. Se houver dispositivo danificado, não improvisar reparo; isolar conforme instrução do fabricante e protocolo

institucional, sem cortar ou manipular segmento.

8. Comunicar achados e horários ao prescritor/serviço de acesso vascular; documentar decisão sobre suspensão,

avaliação, continuidade terapêutica e orientações ao paciente.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Não infundir nem forçar desobstrução diante de resistência, dor, edema, extravasamento, migração ou dano; SAMU 192 se instabilidade, dispneia súbita, dor torácica ou sinais de sepse grave.

8. Cuidados posteriores e orientações

Ensinar sinais de infecção e trombose, proteção do curativo, higiene das mãos, não manipulação por pessoas não treinadas e contato imediato com serviço assistente.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação e consentimento; modalidade; horário de início e evolução; queixas, antecedentes e sinais objetivos; avaliação e decisão clínica; ações e responsáveis; acionamentos e horários; resposta, orientações, destino e continuidade; assinatura do enfermeiro e trilha de auditoria na Carteira Digital ONEMA.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC. CLABSI Basics — sinais e tipos de acesso

https://www.cdc.gov/clabsi/about/

MedlinePlus. Central line infections — patient instructions (revisão 2026)

https://www.medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000474.htm

Pontos para revisão do RT: escopo de autonomia e protocolos locais; aplicabilidade ao atendimento remoto; compatibilidade de insumos e dispositivos; fluxo de referência/contrarreferência; verificação de versão e seção de cada fonte.